내시경이 정상인데 왜 계속 쓰릴까요?

기능성·과민성 소화불량의 이해와 관리 — 약을 끊으면 재발하는 쓰림, 그 이유와 단계적 해법을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내시경이 깨끗한데도 증상이 있는 이유

뇌–장 상호작용 장애 — 눈에 보이는 상처가 아니라, 신경이 예민해진 상태입니다

내장이 예민해짐(내장 과민성)

정상이면 못 느낄 산·팽창 자극을 식도·위 신경이 통증으로 느낍니다.

위가 잘 늘어나지 않음(위 적응 장애)

음식이 들어와도 위가 잘 늘지 않아 조금만 먹어도 더부룩하고 금세 배부릅니다.

십이지장의 미세한 염증

내시경에 안 보이는 미세한 염증·변화가 신경을 더 예민하게 만듭니다.

꾀병이 아닙니다

신경·운동·미세 염증이 얽힌 실제 생리적 이상입니다. 그래서 산약만으로는 잘 안 듣고, 끊으면 재발합니다.



설명용 그림 · 뇌와 위를 잇는 신경 신호가 예민해진 상태 — 상처가 없어도 아프고 쓰릴 수 있습니다.

Tip · 상처(궤양·식도염)가 없어도 신경이 예민하면 똑같이 아프고 쓰릴 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 뇌–장 상호작용 장애 분류

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

흔한 오해 세 가지 — 바로잡기

이 오해들 때문에 치료가 엉뚱한 방향으로 흐르기 쉽습니다

01

“위산만 줄이면 낫는다”

산은 원인의 일부일 뿐입니다. 그래서 산약이 ‘조금’만 듣고, 끊으면 재발합니다.

산과 함께 신경 과민도 다스립니다

02

“자다 깨는 건 저혈당 때문”

밤에 혈당이 떨어졌다 튀어 오르는 현상(소모기 현상) 같은 원인은 실제로는 드뭅니다.

밤 증상은 대개 역류·신경 과민

03

“신경성 = 꾀병”

‘신경성’은 꾀병이 아니라 장 신경이 실제로 예민해진 의학적 상태입니다.

의지가 아니라 치료가 되는 병

Tip · 증상이 오래가도 스스로를 탓하지 마세요 — 치료 방향을 바꾸면 좋아질 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 기능성 위장장애 환자 교육 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 무엇을 확인하나요 — 필요한 검사

다른 병이 숨어 있지 않은지 확인한 뒤, 안심하고 과민성 치료로 넘어갑니다

검사	왜 하나요
식도 조직검사	내시경이 정상으로 보여도 호산구식도염(알레르기성 식도염)을 놓치지 않으려고 조직을 떼어 봅니다.
헬리코박터 검사·제균	균이 있으면 없애는 것만으로 소화불량이 좋아지는 분이 있어 먼저 확인합니다.
식도 산도·임피던스 검사 · 필요할 때	산성·비산성 역류와 증상이 함께 나타나는지 살펴, 증상이 산 때문인지 예민함 때문인지 가립니다.
식도 운동(내압) 검사 · 필요할 때	식도 운동·삼킴 장애 같은 다른 원인을 함께 가려냅니다.
위 배출 검사	식후 더부룩함·구토가 두드러질 때 위가 비워지는 속도를 확인합니다.

왜 검사하나요 '병을 찾으려고'가 아니라, 위험한 병을 배제하고 안심하기 위해서입니다.

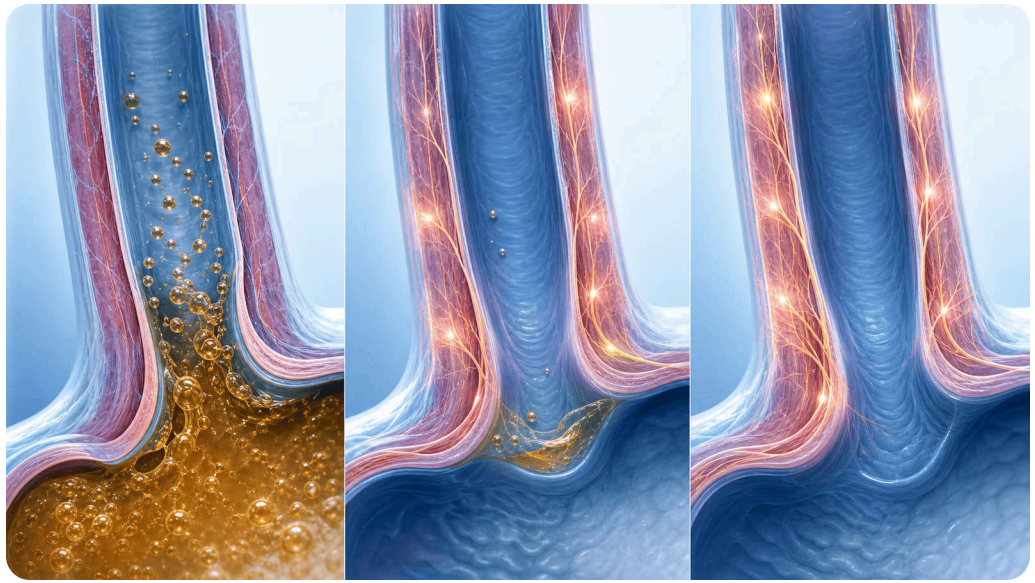
Tip · 모든 검사를 다 하지는 않습니다 — 증상에 맞춰 필요한 것만 합니다.

근거 · 난치성 위·식도 증상 평가 권고 · 식도 조직검사 · 식도 산도·임피던스 검사 · 위 배출 검사

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

같은 '쓰림'도 세 가지 유형으로 나뉩니다

유형에 따라 치료가 달라집니다 — 그래서 구분이 중요합니다



설명용 그림 · 왼쪽부터 산이 많은 경우, 산은 적은데 신경이 예민한 경우, 산이 거의 없는데 신경이 예민한 경우입니다.

1 진짜 산 역류 — 산약이 잘 들음

위산이 실제로 많이 올라옵니다. 내시경은 정상이지만 식도에 산이 닿는 시간이 늘어난 상태(비미란성 역류질환)입니다.

2 역류 과민성 — 신경 조절이 핵심

산이 닿는 양은 정상인데, 정상 범위의 역류에도 예민하게 반응해 쓰림을 느낍니다.

3 기능성 가슴쓰림 — 신경·행동 치료 중심

증상이 산과 거의 관계없습니다. 식도 신경의 과민이 주원인이라 산약보다 신경·행동 치료가 중심입니다.

Tip · 유형은 필요할 때 식도 산도·임피던스 검사로 산성·비산성 역류와 증상의 관계를 보고 가립니다.

근거 · 로마 IV 식도 질환 분류 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

치료의 큰 그림 — 발상의 전환

안 들으면 '더 센 산약'이 아니라, '다른 종류의 치료'로 방향을 바꿉니다

1단계 — 산약을 '제대로'

식사 30분 전에 먹기 · 필요하면 아침·저녁으로 나눠 밤 증상까지 덮기 · 그래도 부족하면 더 빠르고 강한 칼륨경쟁적 위산억제제로 바꾸기.

? 여기까지 했는데도 남는다면

'산이 부족해서'가 아니라 신경이 예민해서일 가능성이 큽니다.

2단계 — 방향 전환

더 센 산약 ✕ — 산을 더 줄여도 예민함은 그대로입니다. 신경을 다스리는 약 ○ · 호흡·수면·식사 같은 생활·행동 교정 ○.



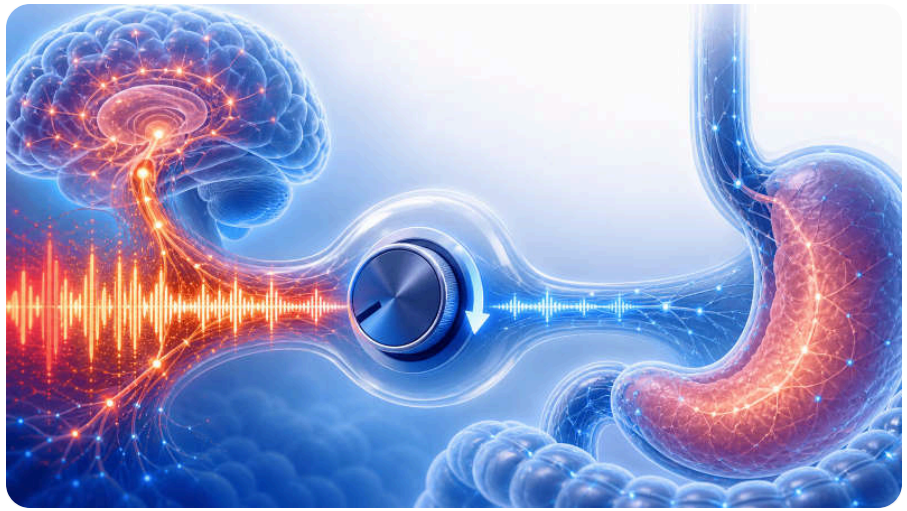
설명용 그림 · 산약 길에서 신경·생활 치료 쪽으로 방향을 바꾸는 갈림길입니다.

Tip · "약을 끊으면 재발"한다면 — "신경 과민을 다스리는 치료로 전환"이 회복의 갈림길입니다.

근거 · 난치성 역류·기능성 소화불량 단계적 치료 권고(위산억제제 최적화 → 신경조절)

신경을 다스리는 약 — 예민해진 신경의 '볼륨'을 낮춥니다

우울증 치료가 목적이 아닙니다 — 우울증 용량보다 훨씬 낮은 용량으로 시작합니다



설명용 그림 · 신경을 끄는 것이 아니라, 너무 크게 켜진 통증 신호의 볼륨을 낮추는 약입니다.

통증·타는 느낌이 주된 경우

저용량 삼환계 약(아미트립틸린) — 통증 신호 자체를 무디게 해 쓰림·타는 느낌을 줄입니다. 잠들기 전에 적은 양으로 시작합니다.

더부룩함·일찍 배부름·체중 감소가 주된 경우

미르타자핀 — 입맛·메스꺼움·일찍 배부름에 도움(체중이 빠질 때 이점) · 부스피론 — 위가 잘 늘어나게 도와 식후 팽만 완화 · 아코티아미드 — 위 운동을 도와 식후 불편 감소

효과는 2~4주에 걸쳐

증상 '유형'에 맞춰 약을 고르고, 효과는 보통 2~4주에 걸쳐 서서히 나타납니다.

Tip · 효과가 서서히 나타나므로 스스로 끊지 말고 진료 때 상의하세요.

근거 · 로마재단 신경조절제 보고서 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

속쓰림, 먼저 위치와 느낌을 나눠요

명치가 불편한지 가슴이 쓰린지에 따라 접근이 달라집니다.

명치 쪽이 불편해요

기능성 소화불량을 살핍니다.

- 식후 가득 찬 느낌·조금 먹어도 배부름
- 명치 통증·명치가 타는 느낌
- 기질적 원인을 배제한 뒤 우세한 증상에 따라 치료

vs

가슴이 쓰려요

역류와 과민성을 살핍니다.

- 가슴쓰림·신물역류
- 내시경과 필요할 때 산도검사로 평가
- 산 노출과 증상-역류 관련성에 따라 구분

위와 뇌는 서로 신호를 주고받습니다

과민성은 통증을 받아들이고 조절하는 경로와 관련됩니다.

통증을 조절하는 경로

뇌에서 내려오는 신호는 통증을 억제하는 브레이크처럼 작용합니다.
세로토닌·노르에피네프린 경로가 소개됐습니다.

치료의 방향

위산이 중심이면 산 억제 치료를, 과민성이 중심이면 장-뇌 상호작용을 조절하는 치료를 고려합니다.



위장관과 뇌 사이의 신호 전달과 통증 조절을 설명합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

정상 내시경 뒤에도 세 가지가 다릅니다

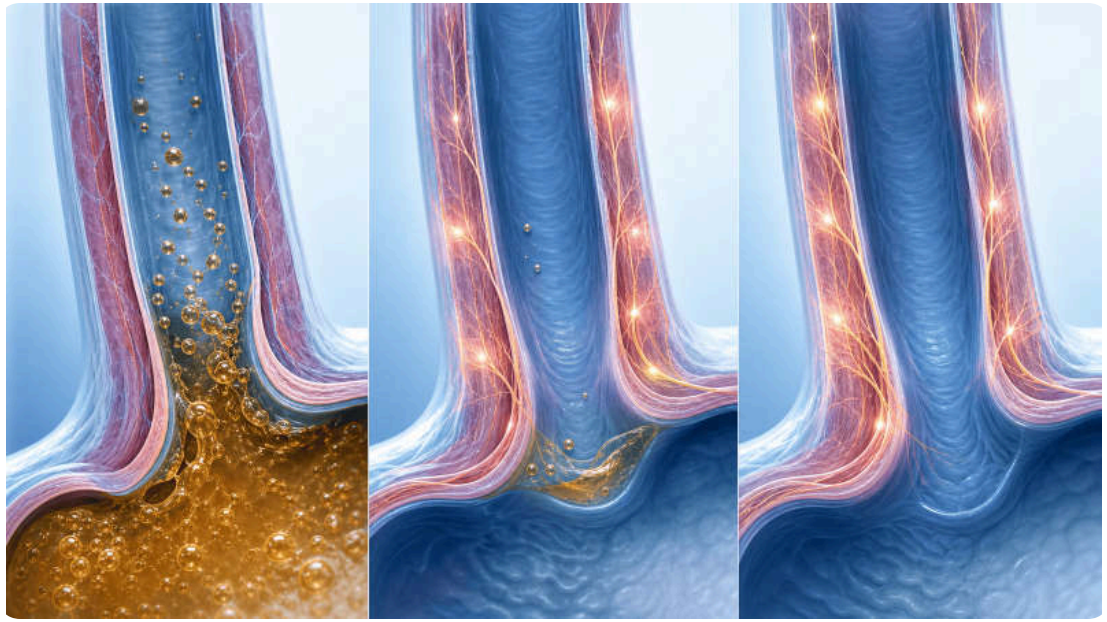
산도검사는 위산 노출과 증상의 연결을 구분하는 데 쓰입니다.

비정상 산 노출

내시경이 정상이어도 위산 노출이 비정상적으로 많으면 비미란성 역류질환입니다.

정상 산 노출

역류와 증상이 연결되면 역류과민성, 연결되지 않으면 기능성 가슴쓰림으로 구분합니다.



비정상 위산 노출과 정상 노출에서의 과민성·가슴쓰림을 나눈 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약이 듣지 않으면 다시 평가합니다

PPI 두 배 용량 불응이 곧 역류질환 배제는 아닙니다.

1

약물 시험치료

전형적인 가슴쓰림에서는 PPI·P-CAB 시험치료를 고려합니다.

2

호전·불응 구분

반응이 충분한지, 다른 증상만 남았는지 살핍니다.

3

24시간 산도검사

비정상 산 노출과 증상-역류 관련성을 평가합니다.

4

원인에 맞는 치료

역류질환 또는 식도 과민성 치료로 이어갑니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

명치 불편감도 아형에 맞춰 치료해요

식후 포만감·조기포만감과 명치 통증·타는 느낌을 나눕니다.

식후불편감증후군

식후 2시간 이내 포만감·조기포만감

- 위장운동촉진제를 먼저 고려합니다.
- 필요에 따라 PPI를 함께 사용합니다.
- 포만감이나 조기포만감이 하나라도 동반되는지 살핍니다.

vs

명치통증증후군

명치 통증·명치가 타는 느낌이 중심

- PPI를 먼저 고려합니다.
- 필요에 따라 위장운동촉진제를 함께 씁니다.
- 식사 시작·악화가 50% 이상이면 식사 연관형으로 구분합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

잘 먹지 못하거나 일찍 배부를 때

김도훈 연자 Q&A · 우세한 증상에 맞춘 선택적 치료 예입니다.

먹지 못해 살이 빠질 때

Mirtazapine은 체중 감소가 동반된 환자에서 고려할 수 있다고 설명했습니다. PDS 예시 용량은 15mg입니다.

조기포만감이 두드러질 때

Buspirone은 위저부의 이완을 도와 조기포만감에 사용한다고 소개했습니다. Q&A 예시는 10mg 하루 3회입니다.

치료 전 다시 볼 것

약을 일률적으로 더하기보다 가장 불편한 증상과 진단, 기존 치료에 대한 반응을 먼저 살핍니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

PPI의 복용 시간과 안정되는 시간을 봅니다

위산 펌프의 활성화에 맞춰 작용하는 약입니다.

3–5일

식사 전에 복용

PPI는 식사 30분–1시간 전에 복용하면 활성화된 펌프를 많이 차단할 수 있습니다.

안정된 약효

매일 새로 만들어지는 20–25%의 펌프까지 억제하는 데 3–5일이 걸립니다.

P-CAB의 특징

식사와 무관하며 첫 복용 1시간 이내 작용, 첫날 최대 억제로 소개됐습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

역류를 줄이는 추가 치료도 있습니다

약의 역할과 주의 조건을 나누어 봅니다.

Baclofen의 역할

일과성 하부식도괄약근 이완을 줄여 역류를 막는 방향으로 작용합니다. PPI 저반응 환자에게 추가하는 방법이 소개됐습니다.

장기 단독요법은 피합니다

장기 사용 시 부작용이 두드러져 PPI 없이 단독으로 오래 사용하는 것은 권장하지 않았습니다.

시작과 증량

강의는 5–10mg의 저용량부터 점진적으로 올리고 하루 60mg을 넘기지 않도록 제시했습니다.

알긴산 장벽 형성제

위 내용물 위에 겔층을 만들거나 점성 물질로 산 주머니를 덮는 기전으로 설명됐습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

신경조절제는 과민한 통증 신호를 조절합니다

김도훈 연자 Q&A · 저용량으로 장-뇌 상호작용을 치료하는 목적입니다.

왜 사용하는가요

우울하거나 불안해서만 사용하는 약이 아니라 위장관이 과민해진 상태를 조절하기 위해 저용량을 쓴다고 설명했습니다.

어떤 약들이 있나요

TCA·SSRI·SNRI·trazodone이 소개됐습니다. 약의 특성·통증·동반 증상·부작용을 고려합니다.

반응이 충분하지 않을 때

기존 신경조절제에 반응하지 않으면 gabapentin·pregabalin 계열을 보조적으로 고려하는 내용이 제시됐습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

저용량 치료의 실제 예를 살펴봅니다

김도훈 연자 Q&A · 처방은 환자의 증상과 반응에 맞춰 조절합니다.

증상 유형	Q&A의 약제 예	시작·조절 예
명치 통증·타는 느낌	Amitriptyline	취침 전 10mg부터 시작 1–2주 간격으로 10mg씩 증량
명치 통증·타는 느낌	Imipramine	25mg에서 시작해 50mg까지
식후 불편감	Mirtazapine	15mg
식후 불편감	Buspirone	10mg 하루 3회

Amitriptyline은 보통 20–30mg이면 충분하며, Q&A에서 소개한 지침 최대범위는 30–50mg/일입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

변비와 소화불량이 함께 있다면

정기욱 연자 Q&A · 약을 더하기 전에 주증상과 진단을 다시 봅니다.

한 약제를 충분히 조절

여러 신경조절제를 동시에 더하기보다 가장 문제인 증상에 맞춰 한 약제의 효과와 부작용을 보겠다고 답했습니다.

변비를 먼저 교정하기도

IBS·FD가 겹치고 변비와 상부 증상이 함께 있으면 완하제로 변비를 교정하는 것만으로 상부 증상이 좋아지기도 합니다.

증상에 맞춘 선택

내장 통증·설사형 IBS에는 저용량 TCA, 식후 증상이 두드러지는 일부 FD에는 buspirone을 선택적으로 고려합니다.

추가보다 재평가

Mirtazapine·escitalopram·duloxetine을 위장관 증상만을 위해 일률적으로 더하지는 않는다고 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복용 중인 약을 함께 알려 주세요

김효원 연자 Q&A · 소아 ADHD 치료 중 약물 병용에 관한 답변입니다.

ADHD 약 복용 중인가요

내장과민성·목 이물감 등으로 다른 약을 처방받을 때 현재 복용 약을 함께 알려 줍니다.

에나폰·Wellbutrin

에나폰 같은 TCA와 Wellbutrin은 교감신경계 작용 때문에 ADHD 약과 잘 함께 쓰지 않는다고 답했습니다.

다른 약을 고려할 때

연자는 ADHD 약과 SSRI 계열은 대부분 함께 사용할 수 있다고 설명했습니다. 개별 병용 약과 부작용을 함께 평가합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

갑자기 눈이 아프거나 잘 안 보이면

성경림 연자 Q&A · 약물 사용과 급성 폐쇄각 위험에 관한 설명입니다.

관련된 약제

TCA·사환계 항우울제와 항콜린 작용이 있는 일부 약은 급성 폐쇄각을 일으킬 수 있는 약으로 소개됐습니다.

즉시 안과 진료

갑작스러운 안통·시력저하가 생기면 즉시 안과 진료를 받습니다. 두통·구토가 함께 생길 수 있습니다.

약물 사용 뒤 눈 증상

연자는 약물 사용 중 갑작스러운 안통이나 시력 저하가 생기면 즉시 안과 진료를 받도록 안내하는 것이 실질적인 대응책이라고 답했습니다.

개별적으로 판단해요

연자는 모든 관련 약을 일괄 절대금기로 삼기 어렵고 문진만으로 개방각·폐쇄각 구분도 어렵다고 답했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

목 이물감이 계속 남는다면

김도훈 연자 Q&A · 가슴쓰림 호전 뒤에도 남는 증상의 접근입니다.

전형 증상 동반 여부

Globus는 전형적인 가슴쓰림이 함께 있을 때 치료가 더 잘 된다고 설명했습니다.

지속되면 다른 진료도

신경조절제를 더해도 증상이 지속될 때 이비인후과 진료를 권한다고 답했습니다.

추가 치료의 예

Q&A는 gabapentin 300mg 하루 3회에서 약 66%까지 호전된 보고도 소개했습니다. 개별 진료에서 선택하는 방법입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료를 더할수록 진단도 더 분명하게

장기치료·증량·시술 전에는 객관적 근거를 확인합니다.

기질적 원인부터

내시경 등으로 기질적 원인을 배제하고, 명치 증상인지 가슴쓰림인지에 따라 접근합니다.

역류 근거를 확인

장기 유지치료·약제 증량·수술 또는 내시경 치료를 결정할 때는 역류 관련 내시경·검사 근거를 확인합니다.



검사 결과와 가장 불편한 증상을 연결해 치료 방향을 정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약의 부작용과 주의할 점

적은 양으로 시작해 천천히 올립니다 — 지금 드시는 약을 모두 알려 주세요

약	흔한 부작용 · 주의	먹는 법
아미트립틸린 (삼환계)	입 마름·변비·졸림·체중 증가·일어설 때 어지러움, 드물게 소변보기 어려움·녹내장 악화, 많은 양에서 심전도 변화. 어르신·심장병이 있으면 낙상 주의	잠들기 전 적은 양으로 시작, 천천히 올림
미르타자핀	졸림·식욕 증가·체중 증가(체중이 빠지는 분에겐 오히려 도움), 드물게 백혈구 감소	잠들기 전, 혈액 이상이 있으면 점검
부스피론	어지럼·두통·메스꺼움. 자몽·일부 무좀약(케토코나졸)과 상호작용, 일부 우울증약(MAO 억제제)과는 함께 쓰지 않음, 세로토닌 증후군 주의	비교적 순함, 식전에 먹어 위가 잘 늘어나게
아코티아미드	대개 잘 맞음. 가벼운 설사·메스꺼움, 드물게 간 수치 상승	식전, 필요하면 간 수치 확인

Tip · 가벼운 부작용은 연락해 용량을 조정합니다 — 고열·혼란·근육 경직이 생기면 약을 멈추고 바로 응급실로 가세요.

근거 · 각 약 허가사항 · 로마재단 신경조절제 보고서 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

상황에 맞춰 더하는 보조 선택지

증상과 상황에 맞춰 골라 더하는 보조적인 방법입니다

01

위장운동 촉진제

이토프리드·모사프라이드·아코티아미드 — 위가 잘 비워지게 도와 식후 더부룩함·일찍 배부름을 줄입니다.

식후 더부룩할 때

02

알긴산 제제(가비스콘)

식후 위 윗부분에 뜨는 산 주머니를 막아 식후 역류·쓰림을 빠르게 가라앉힙니다.

식후 쓰림이 심할 때

03

바클로펜

잦은 트림·되새김이 함께 있을 때 더해 봅니다. 식도 아래 조임근이 풀리는 것을 줄입니다.

트림·되새김이 있을 때

04

헬리코박터 제균

감염이 확인되면 제균합니다. 일부 환자는 제균만으로 소화불량이 좋아집니다.

감염이 확인되면

Tip · 보조 약은 주 치료를 돕는 역할입니다 — 증상에 맞는 것만 골라 씁니다.

근거 · 보조 약 권고(위장운동 촉진제·알긴산 제제·바클로펜) · 헬리코박터 제균

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

생활습관 — '끊을 음식이 없다'가 '할 게 없다'는 아닙니다

금지 음식 목록보다 신경을 안정시키는 습관이 더 중요합니다 — 우선순위 순서대로

1 · 횡격막(복식) 호흡 — 특히 식후

이 유형에서 무작위 대조 연구로 근거가 있는 유일한 방법입니다. 연습은 다음 장에서 봅니다.

2 · 충분한 수면

잠이 부족하면 통증이 더 예민해집니다. 규칙적인 수면이 곧 치료입니다.

3 · 조금씩·천천히·기름기 적게

조금씩 천천히, 기름진 음식은 줄이고, 저녁은 잠들기 3시간 전까지 마칩니다.

4 · 2주 식품일기 쓰기

'내' 유발 음식을 기록으로 찾습니다. 배가 많이 부풀면 저포드맵 식사 4주 시도를 진료 때 상의하세요.

5 · 밤 증상이 있으면

침대 머리 쪽을 10~15cm 올리고 왼쪽으로 누워 자면 밤사이 역류가 줄어듭니다.

알아 둘 점

정상 체중이면 체중 감량은 해당되지 않습니다. 생활습관 교정의 근거는 전반적으로 약한 편이라, 약물 치료를 돕는 보조 축으로 함께 합니다.

Tip · 저포드맵 식사는 장에서 발효되기 쉬운 탄수화물을 줄이는 방법입니다 — 모든 분에게 효과가 있지는 않습니다.

근거 · 횡격막 호흡 무작위 연구 · 수면–통증 연관 · 식사 유발 음식·저포드맵 · 밤 역류 자세

행동·심리 치료 — 신경 과민을 직접 낮춥니다

약에 못지않게 효과가 오래갑니다 — 뇌–장 연결을 직접 다스리는 방법입니다

횡격막 호흡 훈련

배로 천천히 쉬는 훈련을 반복하면 자율신경이 안정되고 식후 역류·트림이 줄어듭니다.

인지행동치료 · 장 지향 최면치료

예민해진 뇌–장 회로를 다시 길들이는 치료입니다. 약물에 견줄 만하고 효과가 오래 갑니다.

스트레스·자율신경 관리

규칙적인 생활·이완·가벼운 운동으로 스트레스를 낮추면 장 신경의 예민함도 함께 가라앉습니다.



설명용 그림 · 배에 손을 얹고 천천히 숨을 들이쉬면 배가 부풀어 오릅니다 — 복식호흡 자세입니다.

Tip · 호흡 훈련은 오늘부터 집에서 바로 시작할 수 있습니다.

근거 · 뇌–장 행동치료(인지행동치료·장 지향 최면) 권고 · 호흡 훈련

단계별 관리 — 한 단계씩 차근차근

조급해하지 않고, 함께 한 단계씩 올라갑니다

1

위험 신호 확인

다른 병 배제

위험 증상을 점검하고, 식도 조직검사·헬리코박터 검사로 숨은 병을 먼저 가려냅니다.

2

산약 제대로

최적화

식전 30분·나눠 먹기·칼륨경쟁적 위산억제제로 바꾸기까지. 그래도 남으면 다음 단계로.

3

유형 확인 + 신경 약

적은 양부터

유형을 확인하고, 증상에 맞는 신경조절제를 적은 양으로 시작합니다.

4

행동·생활 교정

어려우면 의뢰

호흡·인지행동치료·생활 교정을 함께 하고, 그래도 어려우면 전문 진료로 연계합니다.

핵심 산약만 계속 올리지 말고, 제대로 써도 남으면 신경을 다스리는 약·행동 치료로 방향을 바꿉니다.

Tip · 한 번에 끝내는 약은 없지만, 단계를 밟으면 좋아질 수 있습니다.

근거 · 로마 IV 기준 2016 · 난치성 기능성 소화불량·식도 과민성 단계적 진료 흐름

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

꾀병이 아닙니다 — 함께, 단계적으로

단계적으로 좋아질 수 있습니다 · 처음 진단받은 분은 한 장 안내문을 함께 보세요

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이런 신호는 넘기지 마세요

피를 토하거나 검은 변은 바로 응급실로. 체중 감소 · 삼키기 어려움 · 빈혈 · 멎지 않는 구토는 '과민성'으로 넘기지 말고 바로 검사합니다.

참고한 자료

로마 IV 기준 2016(뇌–장 상호작용 장애 분류) · 로마재단 신경조절제 보고서 2018 · 각 약 허가사항 · 난치성 위·식도 증상 평가·치료 권고

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 기능성 소화불량 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/functional-dyspepsia/